



TD DE TRAUMATOLOGIE

QCD

- 1) L'un des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax est de maintenir les fonctions respiratoires et circulatoires
- 2) La fracture du poignet est une fracture sus-articulaire de l'extrémité inférieure du radius par hyper flexion
- 3) La luxation incomplète est une subluxation
- 4) La réduction est un geste à proscrire en cas de fracture ouverture de la diaphyse du fémur
- 5) La luxation de l'épaule est dite complète lorsqu'il y'a une interaction entre les deux surfaces articulaires
- 6) Il est recommandé de ne pas faire asseoir le blessé en cas de fracture fermée de la diaphyse du fémur
- 7) En cas de luxation de l'épaule, le signe de l'épaulette est caractérisé par l'impossibilité de l'adduction du bras
- 8) Le ménisque interne a une forme presque en O tandis que l'externe a une forme en C
- 9) Un trauma est une blessure ou une lésion locale produite par une violence interne
- 10) Les lésions vasculo-nerveuses sont secondaires et générales des fractures du fémur
- 11) La luxation de l'épaule est un déplacement permanent plus ou moins important de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre
- 12) Le thorax est constitué d'un contenu fait de la cage thoracique grossièrement cylindrique et fermé en bas par les muscles diaphragmatiques et en haut par la base du cou
- 13) La consolidation en cas de traumatisme du bassin se fait en 60 jours
- 14) En cas de traumatisme du thorax l'inspection apprécie les vibrations vocales et le choc de pointe à l'étape analytique
- 15) L'état de dépendance du patient fait partie du rôle de l'infirmier en préopératoire dans les traumatismes des ménisques
- 16) L'impotence fonctionnelle relative ou absolue est un signe fonctionnel du traumatisme du bassin
- 17) L'état de choc est un syndrome général observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature
- 18) Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes
- 19) La soudaine inefficacité de la pompe cardiaque qui entraîne une chute brutale du débit cardiaque définit le choc cardiogénique
- 20) La précipitation est un geste salvateur dans la C.A.T auprès d'un traumatisé des voies publiques
- 21) L'existence de lésions de l'abdomen est un élément de l'examen du traumatisé conscient des voies publiques
- 22) Les fractures de l'humérus sont des fractures qui concernent le corps et le col de l'os du bras
- 23) Le syndrome de wolkman est dû à l'ischémie provoquée par un plâtre brachiopalmair trop serré et trop fléchi
- 24) Les fractures des deux os de la jambe sont des fractures extra-articulaire
- 25) En absence de complication, la fracture des deux os de l'avant-bras se consolide en 30 à 40 jours

- 26) Dans le traitement du choc traumatique, la reprise de la diurèse témoigne de l'efficacité de la réanimation
- 27) La fracture du tiers moyen de la clavicule représente 60% des fractures claviculaires
- 28) La fracture de pouteau-colles intéresse l'extrémité inférieure du cubitus
- 29) Dans l'évolution de la fracture des deux os de l'avant bras , la consolidation se fait en 40 à 50 jours sauf complication
- 30) La route fait partie de l'appareil extenseur du genou
- 31) Avec un traitement correct, la fracture spiroïdale de la jambe se consolide dans un délai de trois mois en moyenne

QCM

32) Devant toute détresse respiratoire après un traumatisme du thorax , la C.A.T est :

- A. Rétablissement de la continuité
- B. Libération des voies respiratoires
- C. Drainage des épanchements pleuraux
- D. Rétablissement de la volémie
- E. Drainage des voies respiratoires

33) Les gestes à proscrire en cas de traumatisme des voies publiques sont :

- A. La précipitation
- B. La participation
- C. L'empoigne sous les aisselles
- D. Usage du brancard

34) Le diagnostic différentiel de la luxation antéro-interne de l'épaule se fait avec les lésions suivantes:

- A. Fracture du col de l'omoplate
- B. Fracture du col de l'humérus
- C. Fracture de la grosse tubérosité
- D. Fracture du col du radius

35) La fracture du corps du radius et du cubitus sans déplacement se traite par :

- A. Réduction manuelle
- B. Rééducation
- C. Application d'un plâtre le long du bras
- D. Réduction chirurgicale
- E. Mise en place d'une plaque de compression avec des vis

36) Les complications secondaires des traumatismes du bassin sont :

- A. Ouverture cutanée
- B. Thromboembolie
- C. Lésion du rectum
- D. Infection
- E. Lésion de l'urètre

37) Sur les lieux de l'accident, le rôle de l'infirmier en cas de suspicion de fracture de l'humérus consiste à :

- A. Préparer le champ opératoire
- B. Faire une immobilisation provisoire

- C. Faire un pansement aseptique
- D. Sonder le malade
- E. Orienter le blessé vers un centre chirurgicale

38) Les symptômes suivants évoquent le syndrome de wolkman ; lesquels ?

- A. Œdème
- B. Hémarthrose
- C. Douleur plus ou moins vive de l'avant-bras ou la main
- D. Hématome
- E. Impotence fonctionnelle

39) Le traitement d'une fracture déplacée de l'humérus comporte deux temps principaux :

- A. La contention
- B. La rééducation
- C. l'ostéosynthèse
- D. La traction-suspension
- E. La réduction

40) Un patient présente plusieurs fractures sur toutes les parties de son membre supérieur droit ne mettent pas en jeu le pronostic vital. Ce patient est selon vous:

- A. Un polytraumatisé
- B. Un polyfracturé
- C. Un polytraumatisé et un polyfracturé
- D. Un multi-traumatisé

41) Concernant les lésions méniscales :

- A. Il peut s'agir de fissure méniscale
- B. Il peut s'agir de micro-traumatismes répétés
- C. Il peut s'agir de désinsertion du ménisque
- D. Il peut s'agir d'une rupture méniscale
- E. Il peut s'agir d'une torsion méniscale

42) Rôle infirmier en cas de syndrome de wolkman consiste à :

- A. Enlever toute compression
- B. Immobiliser le membre
- C. Prévenir le chirurgien
- D. Faire un pansement large du membre

43) Les complications tardives en cas de fracture des deux os de l'avant-bras sont :

- A. Le syndrome de wolkman
- B. Les cals vicieux
- C. Les lésions nerveuses
- D. Les pseudarthroses
- E. Le lever trop précoce

44) Le traitement de la fracture de la rotule a pour buts :

- A. Immobilisation (genouillère plâtrée en extension
- B. Réduction anatomique
- C. Contention solide
- D. Chirurgie par ostéosynthèse
- E. Récupération de la fonction du genou

- 45) Les deux clichés permettant de poser le diagnostic positif de la luxation de l'épaule sont :**
- A. Cliché de face de l'épaule
 - B. Cliché de profil de l'épaule
 - C. Cliché de face transthoracique
 - D. Cliché de profil transthoracique
- 46) Les complications immédiates de la fracture du fémur sont :**
- A. Choc traumatique et hémorragique
 - B. Cals vicieux
 - C. Raideur du genou
 - D. Lésions vasculo-nerveuses
 - E. Ouverture du foyer de fracture
- 47) Chez un polytraumatisé, il faut pratiquer les gestes suivant:**
- A. Maintenir le rachis cervical
 - B. Assurer la liberté des voies aériennes
 - C. Immobiliser les membres dans une attelle en cas de fracture
 - D. Demander un scanner abdominale en absence de signes cliniques suspects
 - E. Pratiquer l'oxygénothérapie
- 48) Les différents types de choc suite aux traumatismes violents sont :**
- A. Choc opératoire
 - B. Choc hypovolémique
 - C. Choc traumatique
 - D. Choc cardiogénique
 - E. Choc septique
- 49) Les formes topographiques des fractures de la clavicule sont :**
- A. Fracture du tiers externe de la clavicule
 - B. Fracture du tiers supérieur de la clavicule
 - C. Fracture du tiers interne de la clavicule
 - D. Fracture du tiers moyen de la clavicule
- 50) Les signes suivants s'observent en cas de fracture spiroïdale chez un sujet touché à la jambe**
- A. Le fragment inférieur est taillé en V plein
 - B. Le fragment supérieur est taillé en V plein
 - C. Le trait a un aspect spiralé
 - D. Le fragment inférieur est taillé en V creux
 - E. Le trait a un aspect de pyramidal
- 51) Dans le traitement orthopédique du traumatisme du bassin, on recommande :**
- A. Repos au lit sur un plan dur pendant 45 jours
 - B. Une traction continue
 - C. Repos au lit sur un plan confortable pendant 45 jours
 - D. Suspension en hamac pendant 21 jours
 - E. L'ostéosynthèse
- 52) Les signes suivant s'observent en phase de choc compensé**
- A. Pâleur extrême
 - B. Diminution du flux urinaire
 - C. Hémococoncentration

D. Pouls accéléré, imprenable

53) Dans les chocs graves, la thérapeutique doit être:

- A. Ordonnée faisant appel à toutes les ressources pour rétablir l'équilibre détruit
- B. Ordonnée faisant appel à toutes les ressources pour rétablir l'équilibre détruit Précose
- C. Persévérante et prolongée
- D. Courte pour éviter toute complication
- E. Simplifiée par service

54) En cas de fracture de la diaphyse du fémur, le traitement orthopédique chez un enfant de moins de 5 ans, consiste à faire:

- A. Réduction sous anesthésie générale
- B. Traction au ZENITH
- C. Plâtre pelvi-pédieux
- D. Traction par broche transtibiale

55) Les signes fonctionnels en cas de traumatisme des ménisques sont:

- A. Douleur
- B. Blocage
- C. Cri méniscal
- D. Hydarthrose

56) La C.A.T devant toute détresses respiratoire en cas de traumatisme du thorax est :

- A. Libération des voies respiratoires
- B. Rétablissement de la continuité
- C. Drainage des épanchements pleuraux
- D. Rétablissement de la volémie

57) Les différentes variétés topographiques de luxation de l'épaule sont:

- A. En avant: Luxation antérieure
- B. En arrière: Luxation postérieure
- C. En bas: Luxation inférieure
- D. En haut: luxation latérale

58) Après un traumatisme du bassin au cours d'un accident de la voie publique, un patient présente un globe vésical, des douleurs et une urétrorragie. Ce patient présente probablement :

- A. Une rupture intra péritonéale de la vessie
- B. Une rupture extra péritonéale de la vessie
- C. Une rupture de l'urètre
- D. Empâtement sus pelvien

59) Il existe deux étapes dans l'étude des signes en cas de traumatisme du thorax, que sont:

- A. Analytique
- B. Syndromique
- C. Synthétique
- D. Symptomatique

BONNE CHANCE À TOUS